中 华 中 医 药 学 会 标 准

T/CACMXXX—201X

股骨头坏死中医疗效评价标准

The Efficacy Evaluation Criteria of Traditional Chinese Medicine of Osteonecrosis of the Femeral Head

（稿件类型：送审稿）

（本稿完成时间：2018 年 11 月）

201×-××-××发布　　201×-××-××实施

中华中医药学会发布

目　次

前　言 I
引　言 II
股骨头坏死中医疗效评价标准 1
1 范围 1
2 规范性引用文件 1
3 术语和定义 1
4 股骨头坏死中医疗效评价标准 3
4.1 功能评价 3
（1）VAS 视觉模拟评分 3
（2）髋关节屈曲评分 3
（3）行走距离评分 4
（4）评价计分方法 4
4.2 影像评价 5
参考文献 6

前　言

本标准按照 GB/ T 1 .1—2009 给出的规则起草。

本标准由中华中医药学会提出并归口。

本标准中医证候疗效参考 1994 年发布的《中医病证诊断疗效标准》,2002 年发布的《中药新药临床研究指导原则（2002 年版--试行）》,西医疗效标准参考《成人股骨头坏死临床诊疗指南(2016)》与《股骨头坏死临床诊疗规范(2015 年版)》，《基于 X 线的股骨头坏死保髋疗效评价方法研究》，《Committee on Terminology and Classification》，《Traumatic Arthritis of the Hip after Dislocation and Acetabular Fractures: Treatment by Mold Arthroplasty》。将股骨头坏死疗效以临床评价和影像评价等多种因素综合制定定量标准。

本标准起草单位：由中国中医科学院望京医院负责起草，广州中医药大学第一附属医院，大连大学附属中山医院，福建中医药大学，浙江省中医院，中日友好医院，上海曙光医院，中国中医科学院中药研究所，郑州大学第一附属医院，甘肃省中医院，武汉市中医院，洛阳正骨医院，江苏省中医院。

起草组负责人：陈卫衡。

主要执笔人：陈卫衡，何伟，赵德伟，童培建，李子荣，詹红生，林娜，王义生，李盛华，董晓俊，刘又文，沈计荣。

专家组(按姓氏笔划排序)：王和鸣，王义生，王智勇，许 鹏，李子荣，刘又文，朱锦宇，李盛华，孙伟，陈卫衡，何伟，沈计荣，杜炯，张长青，肖鲁伟，林娜，郭万首，赵德伟，赵文海，阎作勤，康鹏德，商洪才，韩永台，童培建，董晓俊，彭昊，彭春龙，曾平，詹红生。

技术顾问：王和鸣，肖鲁伟。

学术秘书：王荣田，李泰贤。

引　言

本次修订的《股骨头坏死中医疗效评价标准》(以下简称《标准》) 以指南的形式发布，主要针对股骨头坏死，制订中医疗效评价标准，供股骨头坏死中医药临床医师，骨伤科讲师与科研工作人员使用。主要目的是推荐有循证医学证据的股骨头坏死中医疗效评价标准，指导临床医务人员在辨证基础上规范使用中医疗效评价标准，有利于中西医结合临床，科研和教学工作。

股骨头坏死采用中医药治疗已经在相关的西医共识和指南中得到推荐，早中期的疗效优势也得到逐步认可。但无论是中医还是西医，目前仍没有多因素、客观、公认的疗效评价标准，通过股骨头坏死文献计量研究发现中医药治疗股骨头坏死研究主要采取髋关节功能 Harris 评分标准、《中医病证诊断疗效标准》、《中药新药临床研究指导原则》疗效判定标准，WOMAC，中华医学会骨科学会百分法等疗效评价标准，同时众多的研究者使用自拟疗效评价标。同时课题组前期研究中发现中华中医药学会于 2002 年修订发布的《成人股骨头缺血性坏死（ZYYXH/T374-2012）》标准中并未涉及股骨头坏死中医疗效评价的内容。由于股骨头坏死中医疗效评价标准较混乱，使其临床研究与科研研究可重复性不高，且疗效之间难以横向比较，不利于中医药治疗股骨头坏死发展。综上所述中医药治疗股骨头坏死急需适用于中医药临床的股骨头坏死中医疗效评价标准，提高股骨头坏死中医药临床医疗及科研研究水平。本标准所列疗效评价标准如遇到不符合本中医疗效评价标准的特殊情况，可根据具体情况按照中医理论进行疗效判定。股骨头坏死的中医疗效评价标准将在临床推广应用中不断完善，在未来循证医学证据的支持下定期修订。

股骨头坏死中医疗效评价标准

1 范围

本《标准》规定了股骨头坏死的中医疗效评价指标及评价方法。

本《标准》适用于股骨头坏死中医疗效评价。

2 规范性引用文件

下列文件对于本《标准》的形成是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅在其所注日期的版本内适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改版) 适用于本文件。

ZY／T001.1-94 《中医病证诊断疗效标准》[1]。

国家药品监督管理局修订，并于 2002 年发布的《中药新药临床研究指导原则》[2](试行)。

GB/T 1.1—2009《标准化工作导则——第 1 部分：标准的结构和编写》

基于 X 线的股骨头坏死保髋疗效评价方法研究[3]

股骨头坏死临床诊疗规范(2015 年版)[4]

成人股骨头坏死临床诊疗指南(2016)[5]

Committee on Terminology and Classification[6]

Traumatic Arthritis of the Hip after Dislocation and Acetabular Fractures: Treatment by Mold Arthroplasty[7]

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

股骨头坏死（Osteonecrosis of the Femeral Head，ONFH）

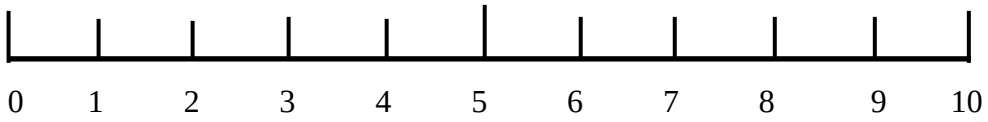
股骨头坏死（ONFH）又称股骨头缺血性坏死（Avascular Necrosis of Femur Head，ANFH）是股骨头血供中断或受损，引起骨细胞及骨髓成分死亡及随后的修复，继而导致股骨头结构改变，股骨头塌陷，关节功能障碍的疾病，是骨科领

域常见的难治性疾病。本病可分为创伤性和非创伤性两大类，前者主要是由股骨颈骨折，髋关节脱位等髋部外伤引起，后者在我国的主要原因为皮质类固醇的应用及酗酒。

4 股骨头坏死中医疗效评价标准

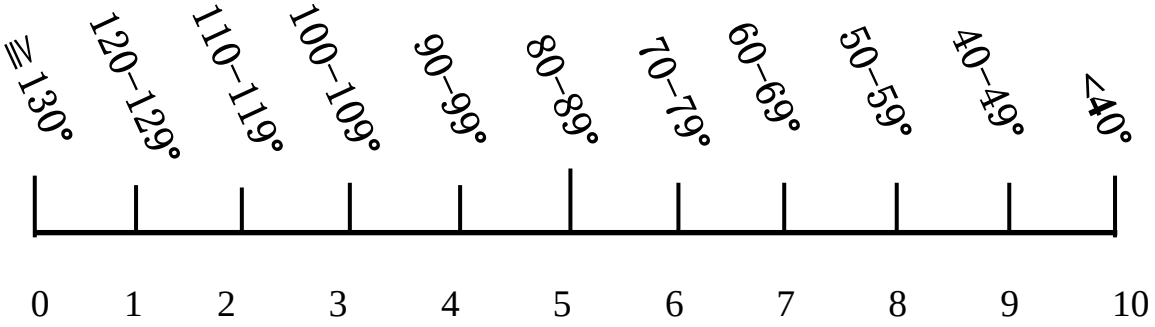
4.1 临床评价

（1）VAS 视觉模拟评分



评价方法：让病人根据自我感觉在横线上划一记号让病人根据疼痛程度，自我在横线上划一记号，最高分为 10 分，最低分为 0 分，分值越高，表示疼痛越重，反之，疼痛越轻。

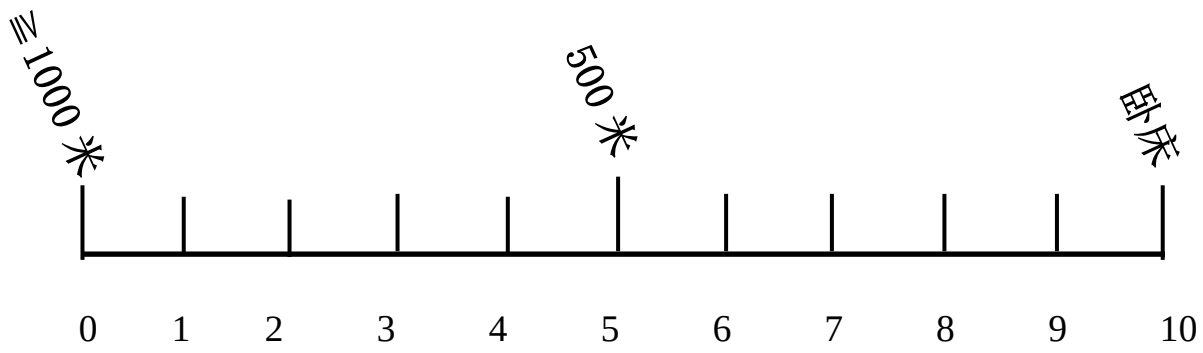
（2）髋关节屈曲评分



评价指标：髋关节屈曲度。

评价方法：髋关节屈曲小于 40 度为 10 分，大于或等于 130 度为 0 分，分值越高，表示功能障碍越重，反之，功能较好。

（3）行走距离评分



评价指标：行走距离。

评价方法：让病人根据平时生活中（无辅助工具）行走距离在横线上划一记号，最高分为 10 分，最低分为 0 分，分值越高，表示行走距离越短，反之，行走距离较长。

（4）评价计分方法

评价指标：疼痛、屈曲功能、行走距离。

评价方法：按照疼痛：屈曲功能：行走距离分别为 5:3:2 的权重比例，取三项指标之和。最高分为 10 分，最低分为 0 分，分值越高，病情越重，反之，病情较轻（见表 1）。

表 1 疗效综合评价方法

指标	分项目评分	系数	总分
疼痛	**0 ~ 10**	**0.5**	**0 ~ 10**
屈曲	**0 ~ 10**	**0.3**	
行走距离	**0 ~ 10**	**0.2**	

4.2 影像评价

股骨头坏死影像评分

评价指标：X 线中股骨头形态、坏死面积、骨关节炎。

评价方法：采用分值计算的方法，形态 0-III级分别记录为 0-3 分；坏死面积 0-III级分别记录为 0-3 分；骨关节炎 0-IV级则分别记录为 0-4 分。积分相加，最高分为 10 分，最低分为 0 分，分值越高，病情越重，反之，病情较轻（见表 2）。

表 2 股骨头坏死 X 线疗效评价

指标	分级	标　准	得分
形态	0	股骨头无塌陷	0
	I	股骨头塌陷<2mm	1
	II	股骨头塌陷 2～4mm	2
	III	股骨头塌陷>4mm	3
面积	0	无囊变	0
	I	坏死面积＜15%以下	1
	II	坏死面积 15～30%	2
	III	坏死面积＞30%以上	3
骨关节炎	0	无改变	0
	I	轻微骨赘	1
	II	明显骨赘，但未累及关节间隙	2
	III	关节间隙中度变窄	3
	IV	关节间隙明显变窄，软骨下骨硬化	4

参考文献

[1] 国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准［M］.南京:南京大学出版社，1994:193，200-201.

[2] 郑筱萸.中药新药临床研究指导原则［M］.北京: 中国医药科技出版社，2002: 354．

[3] 陈卫衡. 基于 X 线的股骨头坏死保髋疗效评价方法研究[J]. 中华关节外科杂志(电子版), 2017, 11(3):4-9.

[4] 李子荣．股骨头坏死临床诊疗规范(2015 年版)[J]. 中华关节外科杂志电子版，2015(1):97-100

[5] 中国医师协会骨科医师分会显微修复工作委员会．成人股骨头坏死临床诊疗指南(2016)[J]. 中华骨科杂志，2016，36(15):945-954.

[6] ARCO(Association Research Circulation Osseous).Committee on Terminology and Classification[J]. ARCO News，1992，4：41-46.

[7] Harris WH.Traumatic Arthritis of the Hip after Dislocation and Acetabular Fractures: Treatment by Mold Arthroplasty[J].J Bone Joint Surg Am.1969，51(4):737-55.